

ABDOMEN

-itis → portal (70-80") → **EXCEPTE** pancreatitis

Dolor ABD, perforat, oclusió, etc → Portal

Isquemia intestinal → S-A-V

Sagnat actiu → S-A-V

Pancreatitis → ⊕ arterial (35-40") → Portal

Traumatismes +/- Tx renals → +/- retardat (10 min)



PPT

Crani: simple + os

Cervical: simple + MPR

Tòrax: arterial (desde Willis)

Abdomen: arterial + portal



MESQ

Simple

- Cranials
- Columna T-L
- Tx

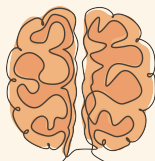
SEMPRE
Reconstruccions
MPR (3 plans)

+/- contrast → Infeccions / Fascitis necrotitzants (80-90" segons distal)

CRANIS

Simple (95%)

TCE → + finestra os +/- { facial
(C1-C2) { òrbites
sins



Codi ICTUS { 1. Simple
2. Perfusió → Temps / Flux / Volum
Penumbra
Core
3. AngioTC (TSA + crani)

Contrast parenquima (3'): LOEs, immunodeprimits...

≠

AngioTC: arterial / venós (smartprep C3)

sagnat en pacients
joves / HSA

1r caròtida
2n jugulars → disparar

EEII

Isquemia: 30-70"

Sagnat: S-A-V

PEDIA

Sempre ECO → Testes / Invaginació: URGENT

Reduir radiació → Comentar { Baixa dosi
Calcular contrast

TÒRAX

- TEP (95%) → Roi en tronc art. pulmonar

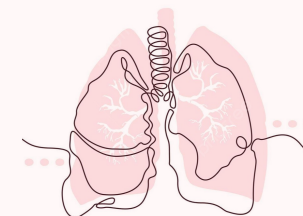
- Sd. VCS → 70"

- Sd. Aòrtic → Tòrax (TSA) - Abd. → S-A-V

- Hemoptisis → ✗ Excepció: per entrar a DIVAS = MAPA vascular

↳ { 200 cc de cop
400 cc en un dia

Angio amb Roi
en Ao descendent



COLL → SEMPRE contrast

95% portal (80") → Cuello standard (DUAL)

Si sagnat → S-A-V (+/- retardat immediat)

Via biliar → 1° ECO

Apendicitis si gordó → TAC

Procediment (drenatge) { CI
Plaquetes / TTPA